

Urinvejsinfektioner (tillæg til nyre- og urinvejssygdomme)

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Opgave 1

Urinvejsinfektioner

- Redegør for patogenesen
- Beskriv kort symptomer
- Beskriv behandling

Urinvejsinfektioner

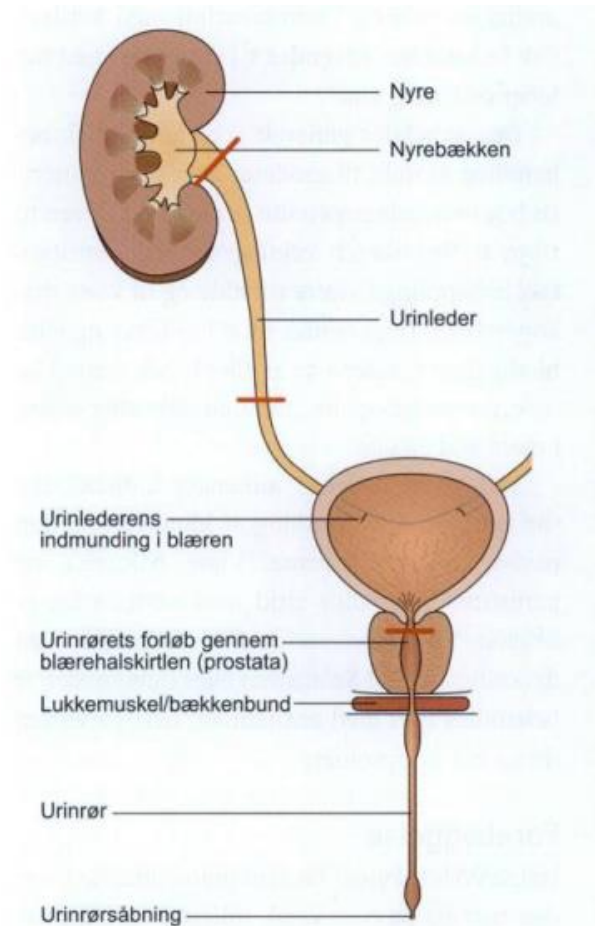
Definition:

Betændelse af slimhinden i urinvejene

- Cystitis (blærebetændelse) → betændelse af slimhinden i urinblæren
- Pyelonefritis (nyrebækken-betændelse) → betændelse af slimhinden i nyrebækkenet
- Urosepsis → bakterier i blodet udgående fra urinvejene

Typer af blærebetændelse:

- Simpel cystitis
 - Enkeltstående tilfælde hos i øvrigt rask ung kvinde
- Kompliceret cystitis
 - Børn
 - Mænd
 - Ældre kvinder
 - Gravide kvinder
 - Recidiverende (gentagne tilfælde) hos yngre kvinder



Figur 14.10. Urinvejenes opbygning. Blokering af afløb kan fx være sten i pelvis (øverst), forsnævring af urinleder (i midten) eller forstørret prostata (nederst).

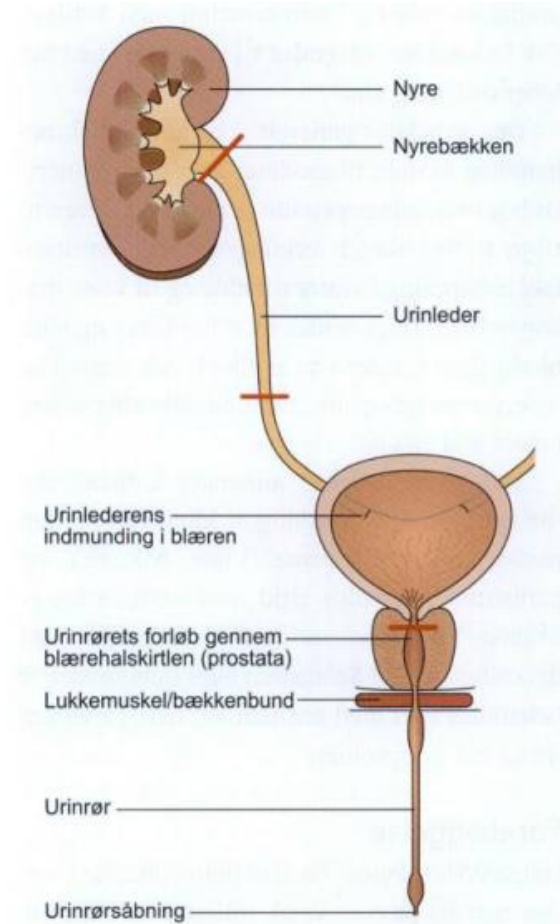
Urinvejsinfektioner

Patogenese:

- Opstår altovervejende ved spredning af bakterier fra MT-kanalen til urinrør
- I blæren kan bakterierne give anledning til **cystitis**
- Yderligere spredning via urinlederne til nyrebækkenet = **pyelonefritis**
- Spredning til blodet = **urosepsis**
- Simpel / recidiverende cystitis:
 - Hyppigst hos kvinder i den fødedygtige alder
 - Tit relateret til samleje
- Komliceret cystitis: Obs. bagvedliggende årsag
 - Strukturelle forandringer i urinvejene (strikturer/forsnævninger, sten eller forstørret prostata med afløbshindring)
 - Instrumentering i urinvejene fx anvendelse af blærekateter, eller urinvejskirurgisk undersøgelse/behandling

Ætiologi

- **E. coli** i 90% af tilfældene – virulensfaktor gør, at de nemt kan klæbe til slimhinde
- På hospital: Enterococcus, Klebsiella, Proteus



Figur 14.10. Urinvejenes opbygning. Blokering af afløb kan fx være sten i pelvis (øverst), forsnævring af urinleder (i midten) eller forstørret prostata (nederst).

Urinvejsinfektioner

Symptomer og fund:

Cystitis

- Pollakisuri (hyppig vandladning)
- Dysuri (smertefuld vandladning)
- Ømhed over blæren
- Fornemmelse af manglende blæretømning
- Evt. ildelugtende blodtilblandet urin

Pyelonefritis

- Feber
- Smerter over lænden / flankerne

Urosepsis

- Påvirket almentilstand
- Feber
- Blodtryksfald



Urinvejsinfektioner

Behandling:

Simpel cystitis

- 50% helbredes spontant
- Tranebærsaft → forsuring af urinen → bakteriedræbende
- Rigeligt væskeindtag → øget urinflow → reducerer antallet af bakterier (dog ikke helbredende)

Asymptomatisk bakteriuri

- Behandles som udgangspunkt ikke (med undtagelser fx gravide)

Symptomatisk UVI

- Antibiotika
 - Cystitis: 3 dage
 - Pyelonefritis: 10-14 dage

Høj feber + almenpåvirkning → obs. urosepsis

- Indlæggelse + i.v. antibiotika

